

Afspraken 2025-2026

FTO Groep Leusderveld

Datum	Onderwerp	Afspraken
2025	CVRM/Duurzaamheid/ Osteoporose	• CVRM: • 1^e keus statine is Rosuvastatine. (Aan de hand van cijfers worden er wel minder andere statine voorgeschreven, waarschijnlijk door waarnemers) • Duurzaamheid: • 1^e voorschriften voorkeur voor poederinhalator tov aerosol (indien mogelijk). Pt die nu aerosol gebruiken (indien mogelijk) omzetten naar poederinhalator. • Geen recepten meer voor miconazol, vitamine D en calciumtabletten. • (Geen evaluatie te kort geleden) • Osteoporose: • Vaker alendroninezuurdrank als alternatief starten. (Niet voorgeschreven) • Identificeren risicogroep 2 (veel corticosteroïden per jaar). (Volgt)
6-11-2025	Obesitas	• Bij patienten met BMI > 40 wordt de contra indicatie morbide obesitas vastgelegd in het dossier (apotheker en huisartsen). • Bij evaluatie na 1 jaar gebruiken alle huisartsen en apotheker de medicatie en doseerdadviezen voor patienten met morbide obesitas. • Afspraak regio tav medicatie voor obesitas op eigen kosten (volgt volgende FTO)

3-02-2026	Communicatie	• Doseringwijzigingen uniform doorgeven: voorbeeldrecept wordt gepresenteerd bij het volgende FTO. • Huisartsen plannen het autoriseren van recepten voortaan in de agenda in, zodat de apotheek minder vaak achter openstaande recepten hoeft aan te bellen (o.a. antibiotica en pijnstillers). • Huisartsen noteren de indicatie of het gebruik vaker en duidelijker op het recept. Er wordt een overzicht gemaakt van middelen waarvoor dit bijzonder relevant is (bijv. DOAC's). • WhatsApp FTO-groep: Het versturen van informatie bij grote nazendingen, inclusief een bijbehorend plan, wordt als prettig ervaren. Dit wordt voortgezet. • Medische noodzaak: Huisartsen geven niet automatisch akkoord voor medische noodzaak, maar verwijzen de patiënt naar de apotheker voor een gesprek. • Er is behoefte gesignaleerd aan regelmatig overleg over polyfarmaciepatiënten; hierover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. • Herhaalmedicatie die oorspronkelijk is geïnitieerd door een specialist wordt niet zonder meer gefiatteerd door de huisarts, conform het NHG-standpunt. Er wordt een plan gemaakt om dit lokaal en mogelijk regionaal op te pakken. • MMC-voorschrijven: Aandacht voor het doorgeven van wijzigingen vanuit het MMC. • Behoeft aan uniformere medicatieoverdracht vanuit de GGZ
-----------	--------------	---

9-04-2026	Huidinfectie en evaluatie osteoporose	• Bij diagnose scabies starten met ivermectine OF permetrine. Bij voorkeur wel recept van huisarts voor deze medicatie ivm vergoeding en indicatiestelling. Apotheker kan naar eigen inzicht op verzoek patient wel éénmalige dosering voor huisgenoten leveren. • Impetigo: Fucidin blijft eerste keus (mupirocine reserve en bij dragerschap) Flucloxacilline is eerste keus. Bij onvoldoende effect adviseert de NHG standaard verwijzing naar de tweede lijn. De expert opinion van een medisch microbioloog is dat je ook clindamycine kunt toevoegen aan flucloxacilline in zo'n geval. • Antibiotica voorschrijven: Gebruik prescriptor en controleer met kinderformularium • Osteoporose preventie is duidelijk verbeterd na het vorige FTO: er is vaker direct gestart met bisfosfonaat bij prednison gebruik.
2-06-2026	ADHD	• Duidelijkheid rondom afgesproken gebruik van ADHD-medicatie bij niet elke dag gebruik. Actie 1 Wanneer ADHD-medicatie niet voor elke dag is (bv. alleen schooldagen) wordt op het recept geschreven op welke dagen het gebruikt wordt, zodat te vroeg ophalen sneller opgespoord kan worden. Resultaatdoelstelling 1 -6 maanden na het FTO is het aantal recepten met zo nodig gebruik zonder aanvullende informatie met 50% afgenomen. • Nieuwe gebruikers van dexamfetamine zijn op de hoogte dat ze moeten kunnen aantonen dat dexamfetamine voor ADHD is. Actie 2 De huisarts en apotheek informeren alle nieuwe

		gebruikers van dexamfetamine die voertuigen besturen dat ze bij een controle moeten kunnen aantonen dat ze dexamfetamine gebruiken voor ADHD. Resultaatdoelstelling 2 6 maanden na het FTO zijn alle nieuwe gebruikers van dexamfetamine op de hoogte van de plicht van tonen gebruik voor ADHD bij het besturen van voertuigen. Daarnaast wordt gecontroleerd of het op de patient-informatie folder staat (actie apotheek) • Het verminderen van de kans op misbruik van ADHD-medicatie. Actie 3 Bij nieuwe patiënten, bij het jaargesprek of bij verslavingsgevoelige patiënten wordt sneller overwogen om langwerkend methylfenidaat voor te schrijven. Resultaatdoelstelling 3 6 maanden na dit FTO wordt bij verslavingsgevoelige patiënten vaker langwerkend methylfenidaat voorgeschreven. -papieren recepten worden ip niet meer geaccepteerd (voorschrijvend arts wordt gebeld).
3-09-2026	Afbouw antidepressiva/ evaluatie obesitas	• Apothekers leveren lijsten aan en huisarts geeft akkoord wie benadeerd mag worden door apotheker of afbouwen mogelijk is (gefaseerd). Pt maken een afspraak op het spreekuur bij huisarts voor begeleiding bij het afbouwen. · • Recept: 1 dosering en dan afbouwschema in regel opschrijven, apotheker levert dan de juiste hoeveelheid tabletten van de verschillende sterktes. · • Na 1 jaar is bij alle patiënten die langer dan 15 maanden antidepressiva gebruiken beoordeeld of afbouwen mogelijk is ·

		• Na 1 jaar is er 5% minder langdurig antidepressiva gebruik. • Obesitas: Afspraken nav FTO Obesitas nogmaals besproken, discussie betreft voorschrijven medicatie GLP1 op eigen kosten (geen conclusie)